

Datos Personales							
Nombre:	VALENTINA ISABEL MEJIA ARREDONDO	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	2016-07-20	Edad	9 Años, 7 Meses, Y 6 Días
Identificación:	TI - 1062404979	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE 5TO DE PRIMARIA
Correo Electrónico:	Santo-0821@hotmail.Com - 1062404979			Dirección:	Cra 8 # 6-26		
Departamento:	CESAR	Municipio:	SAN DIEGO		Zona:	Urbana	
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		NINI ARREDONDO - Parentesco (madre) - Teléfono (3003161454)					

Apertura psicología del 2026-02-19 08:37:17: 9 años, 7 meses, y 6 días

DATOS GENERALES

Remisión

Autorreferido (Particular)

DX principal

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 1

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 2

NREF - NO REFIERE

Código de consulta

890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

Refiere el padre, “a veces se distrae bastante con las cosas, uno le habla y ella queda como pensativa para contestarme algo. A veces pienso que quiere llevarme la contraria, pero si es de las que piensa al decir las cosas, por qué esto por qué lo otro”

Refiere la madre, “nació con RCIU, baja de peso, estuvo en UCI, cuando estaba pequeña no se quedaba quieta para comer “las siestas para ella no existen, no duerme de día y le cuesta conciliar el sueño en la noche” “desde el año pasado dice que ve una niña que la levanta y que le dice que vayan a jugar, que la levanta y le dice que no le diga nada a los papás, y la niña le dice que quiere conocer a sus papás”

Enfermedad Actual

Los padres refieren dificultades emocionales, sociales y conductuales en la menor con curso evolutivo prolongado. Como antecedentes relevantes, la madre indica que la niña nació con restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), bajo peso al nacer y requirió manejo en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Desde la primera infancia describen patrones de regulación atípicos, incluyendo inquietud motora, dificultades para permanecer quieta durante la alimentación y alteraciones del sueño, señalando que “las siestas para ella no existen” y que históricamente ha presentado dificultad para conciliar el sueño. A nivel del desarrollo socioemocional, los padres refieren que la menor ha presentado desde edades tempranas baja iniciativa social, dificultades para establecer vínculos cercanos y escasas amistades, con tendencia al aislamiento relativo. Estas características han sido persistentes y no de aparición reciente. Asimismo, describen rasgos de desatención e inquietud motora desde la infancia. Se reporta que hacia los 4 años se comenzaron a evidenciar cambios en el perfil emocional, con aumento de la inseguridad y mayor sensibilidad interpersonal. Desde los 5 años los síntomas se han agudizado de manera progresiva, caracterizados por inseguridad social, autopercepción negativa y dificultades adaptativas en contextos escolares.

También refieren que la menor suele compararse con su hermano menor, a quien percibe como más sociable y aceptado, manifestando sentimientos recurrentes de exclusión. La niña verbaliza que otros niños no la incluyen y expresa ideas como que “a todos les va bien y a mí no”. En este contexto, se realizó cambio reciente de institución educativa (de Sandiego a Valledupar) debido a dificultades sociales previas; sin embargo, tras el traslado se observó exacerbación del malestar emocional, con rechazo al nuevo colegio, temor al fracaso académico y manifestaciones somáticas como cefaleas en las primeras semanas de adaptación. Como antecedente emocional relevante, se reporta fallecimiento de la abuela paterna hace aproximadamente tres años, tras lo cual la menor ha expresado ideas relacionadas con reunirse con la abuela en el cielo.

Los padres refieren además características persistentes en el estilo cognitivo y comunicativo de la menor, tales como formulación de preguntas complejas para la edad, tendencia a la argumentación lógica reiterativa, rigidez cognitiva y dificultad para aceptar errores o pérdidas en juegos. Describen patrón de pensamiento insistente, repetición de preguntas y elevada necesidad de certeza. Señalan que en contextos escolares la menor participa de manera predominante, generando rechazo por parte de pares, lo que ha contribuido a experiencias de exclusión social. Asimismo, reportan comunicación con tono formal y estilo verbal cercano al adulto, así como dificultades en la flexibilidad emocional ante cambios o frustraciones.

En el último año se describe la aparición de experiencias perceptivas inusuales referidas por la menor, predominantemente en horario nocturno, asociadas a temor intenso y alteraciones del sueño. La madre refiere que desde ese periodo la niña manifiesta ver una figura femenina con la que interactúa. La menor describe estas vivencias de forma vívida, señalando: “Yo estaba durmiendo y sentí que me estaban tocando... luego me vino a decir que quería jugar conmigo y yo estaba asustada”.

La niña refiere la presencia de una figura a la que denomina “una niña”, describiéndola con características físicas definidas y contenido amenazante. Relata que dicha figura le comunica escenas de daño hacia sus familiares: “Un día me dijo cómo iba a ser la muerte de mi familia... que a mi papá lo iba a atropellar un bus... que mi mamá se iba a ahorcar... que mi hermano se iba a ahogar... y a mí un señor me iba a meter un cuchillo por la espalda”.

Asimismo, narra episodios con alto contenido imaginativo en los que refiere haber sido llevada por “guardaespaldas” a una camioneta donde “me pusieron unas gotas y un polvo blanco y me dormí”, describiendo estas escenas con carga emocional significativa. La menor establece asociaciones entre estas experiencias y contenidos audiovisuales previamente observados, indicando que la figura “vive en un circo” y que posteriormente identificó elementos similares en programas de televisión.

En la actualidad, los padres refieren persistencia de inseguridad social, dificultades atencionales, pensamientos rumiativos nocturnos, alteraciones del sueño y necesidad de supervisión en hábitos de autocuidado. Señalan que la menor presenta tendencia a la oposición verbal ocasional, hipersensibilidad a comentarios de terceros y dificultad para integrarse socialmente.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico NO REFIERE	Tóxicos
Traumáticos Otro	Medicación NO REFIERE
Paraclínicos ECOGRAFIAS	Hospitalizaciones SI, POR DENGUE EN DOS OCASIONES.
Patología NO REFIERE	

ANTECEDENTES

Prenatales

Edad De La Madre En El Embarazo 29 AÑOS	Enfermedades De La Madre Otro
Único Embarazo PRIMER	El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica Si
Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo No	Estado De La Madre Durante El Embarazo Gestación Con Antecedente De Restricción Del Crecimiento Intrauterino (RCIU). La Madre Reporta Inestabilidad Emocional Durante El Primer Trimestre Asociada A Diagnóstico De SICA. Durante El Curso Del Embarazo Se Presentó Desprendimiento Placentario, Requiriendo Vigilancia Médica Especializada.

ANTECEDENTES

Natales

Tipo De Nacimiento Cesarea	Causa De La Cesárea Restricción Del Crecimiento Intrauterino (RCIU)
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer 2145
Talla Al Nacer 46	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES

Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido La Menor Requirió Hospitalización En Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales Durante 2 Días Debido A Bajo Peso Al Nacer, Con Evolución Posterior Marcada Por Dificultad Respiratoria, Manejada En Contexto Hospitalario.

ANTECEDENTES

Desarrollo Psicomotor

Control Cefálico 2M	Rolado 3M
Sedente Solo 4M	Gateo 6M
Bípedo Sin Ayuda 7M	Marcha 10M
Lenguaje Verbal 12M	Lenguaje Verbal Fluido 3AÑOS

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión Abuelo Materno	Ansiedad Abuelo Materno
Demencia Abuelo Materno	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos NO REFIERE	Otros NO REFIERE

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa Actualmente cursa grado quinto en el Colegio San Fernando de Valledupar, posterior a cambio institucional reciente desde el municipio de San Diego. La menor muestra mayor afinidad por áreas de tipo exploratorio como ciencias naturales y religión, con interés en actividades prácticas y experimentales. Refiere baja motivación hacia lengua castellana. Se reportan dificultades persistentes en la integración social y establecimiento de vínculos con pares en el entorno escolar.
Historia laboral NO APLICA
Historia familiar Actualmente convive con ambos padres el señor Santiago Mejía de 41 años, la Señora Nini Aredondo de 38 años y un hermano menor Ezequiel Mejía de 5 años. A nivel general se describen relaciones familiares funcionales. La menor refiere vínculo adecuado con los padres, mientras que reporta interacciones conflictivas frecuentes con el hermano menor, caracterizadas por discusiones recurrentes propias de la dinámica fraterna.
Historia social Desde etapas tempranas se describen dificultades en la interacción con pares, con tendencia a estilos comunicativos poco ajustados a la edad y dificultades en reciprocidad social. Los padres refieren patrones de interacción caracterizados por argumentación excesiva, rigidez en juegos y dificultades para integrarse socialmente, con antecedentes de experiencias de rechazo por parte de compañeros.
Historia emocional/afectiva Se describe estilo socioemocional caracterizado por alta sensibilidad a la exclusión social, pensamiento perseverativo y dificultad para la flexibilidad cognitiva, con tendencia a sobreanalizar situaciones y baja tolerancia a la frustración. Cuando logra establecer vínculos de confianza, se muestra afectuosa, atenta y con adecuada disposición al compartir. Se describe apego significativo hacia las figuras parentales, evidenciando mayor seguridad emocional en el contexto familiar cercano.
Historia deportiva Presenta antecedente de práctica deportiva en patinaje desde aproximadamente los 5 años, con continuidad en el interés por esta actividad. Refiere afinidad por la natación, sin vinculación actual a entrenamiento formal o práctica deportiva sistemática.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial Se realizó entrevista semiestructurada orientada a explorar áreas funcionales y afectadas del desarrollo, redes de apoyo, antecedentes evolutivos y contexto familiar, así como a caracterizar la fenomenología de las experiencias perceptivas referidas por la menor. Se aplicó técnica de observación clínica directa durante la interacción, evaluando comportamiento, lenguaje, regulación emocional y coherencia del relato. Durante la entrevista se identifican rasgos cognitivo-conductuales compatibles con estilos de procesamiento rígido, pensamiento lógico precoz para la edad, tendencia a la argumentación formal y dificultades en flexibilidad cognitiva. Asimismo, se administró el Test de la Familia como técnica proyectiva gráfica, con el objetivo de explorar la percepción subjetiva del sistema familiar, posicionamiento emocional dentro del núcleo y calidad de los vínculos afectivos. La integración de técnicas permitió obtener información sobre dinámica familiar percibida, vivencias de pertenencia, recursos emocionales y posibles factores asociados al malestar actual. El dibujo evidencia adecuada organización espacial, trazo controlado y nivel gráfico acorde a la edad, sin indicadores de inmadurez visomotora. Se representan todos los miembros del núcleo familiar con elaboración homogénea, lo cual sugiere percepción integrada del sistema sin distorsiones proyectivas marcadas. El orden de ejecución muestra inicio por la figura materna y ubicación posterior del resto de integrantes, reflejando jerarquías afectivas subjetivas más que alteraciones vinculares estructurales. En conjunto, el material proyectivo es compatible con una representación familiar organizada en el plano simbólico, sin indicadores gráficos concluyentes de conflicto vincular severo dentro de la técnica.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica NO REFIERE
Intervención neurológica NO REFIERE
Intervención neuropsicológica NO REFIERE
Otras intervenciones A los 4 años inició proceso de Terapia Ocupacional, completando aproximadamente 15 sesiones. Según reporte familiar, la profesional tratante identificó dificultades en la concentración como principal hallazgo, descartando compromiso cognitivo significativo durante la valoración.

EXAMEN MENTAL

Examen Mental La menor ingresa a consulta, con presentación personal acorde a la edad y contexto, saludo apropiado. Se muestra alerta, orientada auto y alopsiquicamente. Mantiene actitud colaboradora durante la evaluación, con tono de voz bajo y conducta generalmente tranquila.
--

El lenguaje es comprensible y acorde al desarrollo evolutivo, con adecuada capacidad de expresión y narrativa organizada, aunque con contenido llamativo al referir experiencias perceptivas inusuales. La atención y comprensión se observan globalmente conservadas durante la interacción clínica. En el área perceptiva, la menor refiere experiencias sensorperceptivas complejas compatibles con alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, descritas con alto nivel de detalle y vivencia subjetiva de realidad.. El pensamiento se muestra coherente en forma, sin desorganización formal evidente durante la entrevista. A nivel afectivo se aprecia tono emocional ansioso, con elementos de temor asociados a las vivencias referidas. No se identifican ideas suicidas estructuradas al momento de la valoración, aunque el contenido narrativo incluye temáticas de muerte que requieren seguimiento clínico. A nivel cognitivo, los padres describen buena memoria y desempeño académico global conservado. No se reportan antecedentes neurológicos diagnosticados al momento de la valoración.

Ciclos del Sueño

Se reportan alteraciones en el inicio del sueño, caracterizadas por dificultad para conciliarlo, asociadas a temores nocturnos y experiencias perceptivas referidas por la menor. No se cuenta con valoración especializada por psiquiatría infantil ni neuropediatría hasta el momento, por lo cual no se ha establecido etiología orgánica o neuroquímica.

Apetito

CONSERVADO

Actividades de Autocuidado

Se observa dependencia parcial en actividades de autocuidado, requiriendo supervisión y recordatorios frecuentes por parte de los cuidadores. Se reporta baja adherencia a rutinas de higiene personal, particularmente en el cepillado dental y el arreglo personal (peinado).

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):

NREF - NO REFIERE

Impresión Diagnóstica Relacionada 1

NREF - NO REFIERE

Impresión Diagnóstica Relacionada 2

NREF - NO REFIERE

Establecido por primera vez

Si

Objeto de atención clínica

Rasgos del neurodesarrollo asociados a dificultades en cognición social, flexibilidad cognitiva y procesamiento perceptivo atípico, en estudio. Cuadro relacionado a síntomas de ansiedad infantil asociado a experiencias perceptivas inusuales y dificultades en regulación emocional, sueño e integración social. Requiere valoración interdisciplinaria para diagnóstico diferencial.

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Favorecer la regulación emocional, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la comprensión del perfil neurocognitivo de la paciente, mediante intervención psicoterapéutica y evaluación interdisciplinaria orientada a descartar o confirmar condiciones del neurodesarrollo.

Objetivos Específicos

- Caracterizar el perfil neurocognitivo y socioemocional mediante evaluación interdisciplinaria en neurodesarrollo.
- Identificar y modular factores sensoriales o ambientales que incrementen desregulación emocional o conductual.
- Disminuir activación ansiosa asociada a fenómenos perceptivos.
- Orientar a padres en manejo emocional y validación sin reforzamiento de contenido perceptivo.
- Fortalecer habilidades de cognición social (reciprocidad conversacional, comprensión de claves sociales y ajuste del lenguaje al contexto).
- Promover flexibilidad cognitiva y tolerancia a la frustración frente a cambios, errores o pérdida de control.
- Desarrollar estrategias de regulación emocional ante ansiedad, pensamientos perseverativos y temores nocturnos.
- Favorecer habilidades de interacción social adaptativa y manejo de experiencias de rechazo o exclusión.
- Mejorar hábitos de sueño y reducción de ansiedad nocturna mediante rutinas estructuradas.
- Brindar psicoeducación a cuidadores sobre estilos cognitivos neurodivergentes y estrategias de acompañamiento en casa y escuela.
- Establecer rutinas de higiene del sueño.
- Realizar seguimiento clínico evolutivo de fenomenología sensorperceptiva.
- Articular proceso interdisciplinario para diagnóstico diferencial.

Sugerencias e Interconsultas

- Psiquiatría Infantil (Prioritaria), para diagnóstico diferencial, valoración de fenomenología perceptiva, descarte trastornos psicóticos tempranos y manejo farmacológico si aplica.
- Neuropediatría, para descartar causas neurológicas, trastornos del neurodesarrollo, alteraciones del sueño.
- Neuropsicología, para Perfil cognitivo, funciones ejecutivas, atención, madurez neurodesarrollo, Perfil TEA (Evaluación ADOS-2).

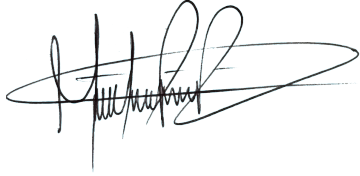
Observaciones y Recomendaciones

OBSERVACIONES

- Presencia de fenómenos perceptivos multimodales persistentes.
- Vulnerabilidad del neurodesarrollo por antecedentes perinatales.
- Alteraciones del sueño que pueden exacerbar sintomatología.
- Impacto funcional en área emocional y social.

RECOMENDACIONES

- Evitar validar contenido literal de las experiencias perceptivas.
- Responder con contención emocional, no confrontación.
- Fortalecer rutinas estructuradas (sueño, higiene, horarios).
- Evitar exposición a contenido audiovisual de terror o paranormal.
- Favorecer sensación de seguridad nocturna (luz tenue, rutinas pre-sueño).
- Mantener comunicación abierta sin sugestionar a la menor.
- No reforzar relatos con interrogatorios extensos.
- Manejo clínico prudente, evitando reforzar interpretaciones sobrenaturales o catastróficas.



DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica

Tarjeta Profesional: 259542

Mag. TP3G - VIU



PRASCA
CENTER

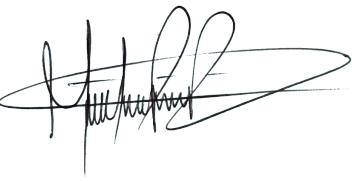
Datos Personales							
Nombre:	VALENTINA ISABEL MEJIA ARREDONDO	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	2016-07-20	Edad	9 Años, 7 Meses, Y 6 Días
Identificación:	TI - 1062404979	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE STO DE PRIMARIA
Correo Electrónico:	Santo-0821@hotmail.Com - 1062404979			Dirección:	Cra 8 # 6-26		
Departamento:	CESAR	Municipio:	SAN DIEGO		Zona:	Urbana	
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		NINI ARREDONDO - Parentesco (madre) - Teléfono (3003161454)					

Impresión Diagnóstica:
NREF - NO REFIERE

Impresión Diagnóstica Relacionada 1
NREF - NO REFIERE

Impresión Diagnóstica Relacionada 2
NREF - NO REFIERE

ÓRDENES MÉDICAS		
No.	PROCEDIMIENTO	CANTIDAD
1	890284 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA OBSERVACIÓN: Psiquiatría Infantil (Prioritaria), Para Diagnóstico Diferencial, Valoración De Fenomenología Perceptiva, Descarte Trastornos Psicóticos Tempranos, Manejo Farmacológico Si Aplica.	1
2	890284 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA OBSERVACIÓN: Psiquiatría Infantil (Prioritaria), Para Diagnóstico Diferencial, Valoración De Fenomenología Perceptiva, Descarte Trastornos Psicóticos Tempranos, Manejo Farmacológico Si Aplica.	1



PRASCA

CENTER

DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica

Tarjeta Profesional: 259542

Mag. TP3G - VIU